



Développement d'outils pour le signalement des retours de l'étranger

Pierre-Etienne Toulemonde, Thibaud Sevin, Alexandra Lomont, Didier Lecointe
Unité Fonctionnelle d'Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections Nosocomiales (UFHHLIN)
Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF), Corbeil-Essonnes



P - 083

INTRODUCTION

La recherche de BHR chez les patients hospitalisés à l'étranger dans l'année précédant leur admission est recommandée par le Haut Conseil de Santé Publique depuis 2013. Le CLIN du CHSF a choisi de dépister également les patients ayant séjourné à l'étranger sans y avoir été hospitalisés. En 2017, l'UFHHLIN accusait un retard considérable dans les rapports de signalement de ces patients, avec un nombre de dossiers en croissance exponentielle.

But : Obtenir un outil permettant de rattraper le retard dans la gestion des signalements pour les patients ayant séjourné à l'étranger.

Objectif : Gérer en temps réel le nombre croissant de rapports de signalement et faciliter la création de rapports annuels d'activité.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Utilisation de 3 fichiers Excel : Excel permet la création de formulaires et le renvoi automatisé de valeurs d'un onglet à l'autre. Les trois fichiers sont donc construits en l'utilisant.

Fichier n°1

Masque infirmier : L'IDE hygiéniste saisit les informations sur le patient et la conformité des PCC (Précautions Complémentaires Contact).

Coller le masque

Masque pour l'obtention de renseignements relatifs aux retours de l'étranger par les IDE hygiénistes :

Effectué à la date du : 27/04/2019
Effectué par : P-E TOULEMONDE

Service ayant adressé le signalement interne à l'UFHHLIN : Musci-ologie

NOM : TOULEMONDE
Prénom : Pierre-Etienne
DDN : 1/04/1987 Sexe : M

Pays de provenance : Wakonda
Date d'admission dans le service : 27/04/2019
Date de retour de l'étranger : 25/04/2019
Date de réception des écouvillons au L2H : 27/04/2019

Notion d'hospitalisation : Non

Dysfonctionnements repérés : PCC BHR non conformes

Si PCC BHR non conformes, motif de non-conformité : Affiche PC non conforme

Demande de l'IDE hygiéniste : Utiliser l'affiche PCC BHR

Commentaires : L'affichette sur la porte était une feuille A4 avec marqué "PCC BHR" dessus.

Légende :

- Nom des différents onglets du fichier
- Rouge = à saisir par le praticien hygiéniste

Le fichier n°3 archive les informations de chaque Signalement effectué ou en cours. Les signalements sont classés par année, ce qui facilite la création de rapports annuels d'activité.

Code	Nom	Prénom	Pays ou établissement si recherche BHR	Hospitalisation à l'étranger	Date de retour de l'étranger	Date d'entrée dans service ayant signalé	Service ayant signalé	Date du 1er prélèvement positif (L2H ou ailleurs)	Résultat recherche BHR	Type de BHR	Résultat recherche BMR	Type de BMR si +	Dysfonctionnements
19-311	XXXXX	XXXXX	Algérie	Non	Non renseigné	31/12/2018	UHCD		Négatif		Négatif		PCC BHR non conformes
19-312	XXXXX	XXXXX	connu 2018	NA	Non renseigné	03/01/2019	Pneumologie		Négatif		Négatif		Néant
19-313	XXXXX	XXXXX	Inde	Oui	03/01/2019	03/01/2019	Neurologie	03/01/2019	Négatif		Négatif		PCC BHR non conformes
19-314	XXXXX	XXXXX	Portugal	Non	Non renseigné	02/01/2019	Pneumologie		Négatif		Négatif		PCC BHR non conformes
19-315	XXXXX	XXXXX	Tunisie	Non	Non renseigné	01/01/2019	Pneumologie		Négatif		Positif	E. coli et C. difficile	Néant
19-316	XXXXX	XXXXX	Congo	Non	Non renseigné	02/01/2019	UHCD		Négatif		Négatif		Néant
19-317	TOULEMONDE	Pierre-Etienne	Wakonda	Non	Non renseigné	27/04/2019	Musci-ologie	27/04/2019	Positif	Tardigrada	Négatif		PCC BHR non conformes

Fichier n°3

Fichier n°2

Grâce à 2 macros, le masque infirmier est copié-collé dans le 1^{er} onglet du fichier n°2 = le **fichier praticien**.

Surveillance et signalement des infections associées aux soins

Rapport de signalement interne

Date de mise en application : Page 1

☒ Vous avez alerté l'UFHHLIN sur une situation potentiellement à risque dans votre service.

Le dossier de cette enquête est enregistré sous le N° SINT : 19-317

Ce rapport est destiné à vous informer des investigations de l'UFHHLIN, étape par étape.

Tout patient faisant l'objet d'un dossier de signalement interne et/ou externe doit être informé par son médecin dans le cadre de sa prise en charge. Une preuve de cette information doit être conservée dans son dossier médical.

Etape 1 = Enregistrement :

Date d'admission dans le service : 27/04/2019

Service ayant adressé le signalement interne à l'UFHHLIN : Musci-ologie

Motif du signalement : Retour de l'étranger

Signalement effectué à la date du : 27/04/2019

Etape 2 = Première série d'investigations :

Effectuées par : P-E TOULEMONDE

Si retour de l'étranger / transfert sanitaire :

NOM : TOULEMONDE

Prénom : Pierre-Etienne

DDN : 1/04/1987 Sexe : M

Pays de provenance : Wakonda

Notion d'hospitalisation : Non

Date de retour de l'étranger : 25/04/2019

Mesures préventives préconisées : ☒ Renforcement des précautions standard PS avec maintien des précautions complémentaires contact PCC BHR

Dysfonctionnements repérés : ☒ PCC BHR non conformes

Motif de non-conformité : Affiche PC non conforme

Commentaire(s) : L'affichette sur la porte était une feuille A4 avec

Etape 3 = Deuxième série d'investigations :

Effectuées par : P-E TOULEMONDE

Mesures préventives préconisées : Maintenir les PCC BHR en attendant les résultats de dépistages

Dysfonctionnements repérés : Affiche "PCC BHR" non conformes

Mesures correctives préconisées : Utiliser la version en vigueur dans Qualinet de l'affiche "PCC BHR"

L'enquête est donc : ☒ Poursuivie

Premier rapport adressé à la date du : 27/04/2019

Renvoi automatique des cases du 1^{er} onglet dans les cases correspondantes du 2^e onglet.

Le praticien hygiéniste saisit les informations manquantes dans les cases rouges du rapport de signalement grâce à cet onglet.

Collage intermédiaire

Masque infirmier

Rapport praticien

Mise en forme

Onglet de mise en forme avant génération du PDF envoyé au service concerné.

Résumé des signalements

Courriel

Rapport praticien

Courriel

Un bouton dans le dernier onglet permet de copier la ligne récapitulant les informations du signalement et d'ouvrir le fichier n°3 = **fichier d'archive**.

Envoi du 2^e volet avec le même onglet que précédemment.

Saisie par le praticien de la 2^e partie de l'onglet « Rapport praticien ».

Lorsque les résultats des dépistages sont rendus par le laboratoire d'hygiène

Etape 4 = Conclusions définitives :

Effectuées par : P-E TOULEMONDE

Résultats de la recherche BHR : ☒ Positif

Résultats de la recherche d'EBLSE : ☒ Négatif

Bactérie identifiée : Tardigrada spallanzani

Commentaires : Détection d'une bactérie hautement résistante aux antibiotiques émergente BHR. Mettre le patient en PCC BHR pendant toute la durée de l'hospitalisation ET à chaque réadmission.

Mesures préventives préconisées : ☒ Maintien des PCC BHR pendant toute l'hospitalisation

Dysfonctionnements repérés : Aucun

Mesures correctives préconisées : Aucun

Le dossier est clos à la date du : 1/04/2019

Rapport final adressé à la date du : 1/04/2019

A : Dr Lecointe ; Dr Lomont ; Dr Sevin

Cc : Toute l'équipe d'hygiène ;

Objet : Signalement interne d'infection nosocomiale n°19-317

Premier rapport

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le premier rapport de signalement à propos d'un patient de retour de l'étranger (Wakonda). Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,

Rapport définitif

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport de signalement définitif à propos d'un patient de retour de l'étranger (Wakonda). Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,

Remplissage automatique des destinataires à partir du service d'accueil du patient de l'onglet Masque infirmier → Envoi du premier rapport de signalement correspondant au PDF précédemment généré

RESULTATS

L'intégralité des opérations prend moins de 10 minutes à chaque signalement. Les rapports de signalement sont harmonisés entre praticiens hygiénistes et plus exhaustifs qu'auparavant. Chaque action est tracée et définie. Cet outil permet d'informer rapidement les services, et de lever les PCC lorsque les dépistages sont négatifs. Ce système draine plus de 85% des signalements de l'UFHHLIN. Les rapports d'activité annuels des signalements d'infection nosocomiale sont facilement extractibles du fichier n°3.

DISCUSSION - CONCLUSION

Discussion : Entre 2014 et 2018, l'augmentation du nombre de rapports de signalements était de 573%. Ce nouveau système a permis de rattraper l'intégralité du retard en quelques mois et de gérer en temps réel les nouveaux signalements.

Perspectives : Une partie importante de cet outil est dédiée aux résultats de l'audit en continu des PCC. Ce système pourrait être adapté à d'autres audits de l'EOH. La prochaine étape pourrait être la création d'une grille d'audit PS sur le même principe. La suivante pourrait être d'insérer directement les dossiers de signalement dans le dossier informatisé du patient.